HALK SAĞLIĞI

YRD. DOÇ. DR. SEDA BEHLÜL

DERS ÇIKTILARI

- Ders 1: Terminoloji, halk sağlığına giriş ve hedefler
- Ders 2: Sağlığın belirleyicileri ve Sağlıklı Yaşam
- Ders 3: Sağlık ölçütleri tanımı ve çeşitleri
- Ders 4: Sağlık ölçütleri çeşitleri devam ve Dünyada ve Türkiye'deki sağlık durumu.
- Ders 5: Epidemiyoloji tarihçesi ve epidemiyolojik çalışma türleri
- Ders 6: Epidemiyolojik çalışma türleri devam
- Ders 7: Kronik hastalık epidemiyolojisi
- Ders 8: Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi
- Ders 9: Anne ve çocuk sağlığı / çocuk aşılama
- Ders 10: Doğurganlık ve Aile planlaması
- Ders 11: Sağlık sistemleri (sağlık hizmetlerinin sunumu ve kullanımı) / Türkiye'de sağlık sistemi
- Ders 12: Çevre sağlığı
- Ders 13: İşçi sağlığı

Ders 3: Öğrenme Çıktıları

- Bu dersin sonunda öğrenci
  - Sağlık ölçütlerinin çeşitlerini ve hesaplamalarını öğrenir.
  - Dünyada ve Türkiye'deki sağlık durumunu açıklar.

DOĞURGANLIK DÜZEYİNİ BELİRLEYEN TEMEL ÖLÇÜTLER

II. **Doğurganlık (Fertilite) Düzeyini Belirleyen Temel Ölçütler**

1. Kaba Doğum Hızı
2. Özel Doğurganlık Hızları
   a. Yaşa Özel
   b. Pariteye Özel
3. Toplam Doğurganlık Hızı
4. Tamamlanmış Doğurganlık Hızı
5. Genel Doğurganlık Hızı
6. Çocuk / Kadın Oranı
7. Nüfus Artış Hızı

KABA DOĞUM HIZI:

- Bir toplumun doğurganlık düzeyini gösteren, duyarlı olmayan bir ölçüttür. Ölçütün paydasında doğurganlığa katkısı olmayan yaşlar ve cinsiyet de yer almaktadır.

$$\text{Kaba Doğum Hızı} = \frac{\text{Bir toplumda bir yılda olan canlı doğum sayısı}}{\text{Aynı toplumun yıl ortası nüfusu}} \times k\,(1000)$$

ÖZEL DOĞURGANLIK HIZLARI

Yaşa Özel Doğum Hızı:

- Kadınlarda doğurganlık döneminde belirli yaşlardaki doğurganlık düzeyini gösteren en duyarlı doğurganlık ölçütüdür. 15-49 yaş grubunda her 5 yıllık yaş aralığı için hesap edilir. Doğurganlığın zaman içinde nasıl bir seyir izlediğini, sunulan aile planlaması hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmek ve farklı toplumların doğurganlık düzeylerini karşılaştırmak amacıyla kullanılır.

$$\text{"X" Yaşına Özel Doğum Hızı} = \frac{\text{Bir toplumda bir yılda "X" yaş grubundaki kadınların yaptığı canlı doğum sayısı}}{\text{Aynı toplumda aynı süredeki "X" yaş grubundaki kadın sayısı}} \times k\,(1000)$$

PARİTEYE ÖZEL DOĞUM HIZI:

Pariteye Özel Doğum Hızı:

- Bir toplumda belirli bir zaman zarfinda belli sayida cocuk dogurmus kadinlarin yaptiklari canli dogum sayisi / ayni toplumda ayni surediki ayni sayida cocuk dogurmus kadinlarin sayisi.
- Gerek aile planlaması hizmetlerinin planlanmasında, gerekse sunulan hizmetlerin en çok hangi gruplarca kullanıldığının belirlenmesinde kullanılır.

$$\text{"X" Pariteye Özel Doğum Hızı} = \frac{\text{Bir toplumda "X" sayıda çocuk doğurmuş kadınların bir yıldaki canlı doğum sayısı}}{\text{Aynı toplumda aynı süredeki "X" sayıda çocuk doğurmuş olan kadın sayısı}} \times k\,(1000)$$

DOĞAL NÜFUS ARTIŞ HIZI:

- Bir bölgedeki nüfusun belli bir süre içinde (genellikle bir yıl) yalnız doğumlar ve ölümlere bağlı olarak değişimine (Yıllık) Doğal Nüfus Artış Hızı denilmektedir. İki farklı şekilde hesap edilebilir:

1- Doğal Nüfus Artış Hızı = Kaba Doğum Hızı - Kaba Ölüm Hızı x 1000

2-

$$\text{Doğal Nüfus Artış Hızı} = \frac{\text{(İçinde bulunulan yılın yıl ortası nüfusu)} \quad \text{(Bir önceki yılın yıl ortası nüfusu)}}{\text{Bir önceki yılın yıl ortası nüfusu}}$$

HASTALIK DÜZEYİNİ BELİRLEYEN TEMEL ÖLÇÜTLER

III. Hastalık (Morbidite) Düzeyini Belirleyen Temel Ölçütler

1. İnsidans
2. Atak Hızları (Primer, Sekonder)
3. Prevalans
   - Nokta Prevalans
   - Süre Prevalans

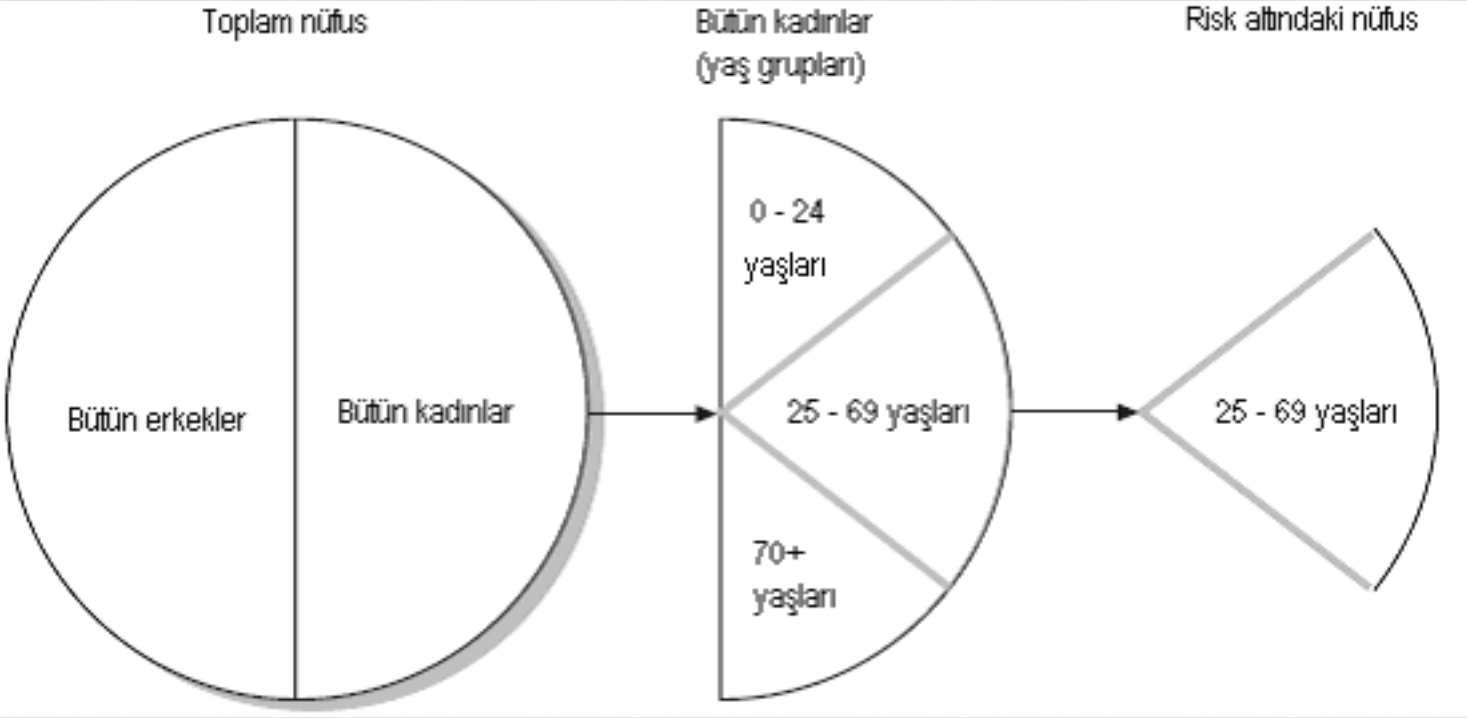
IV. Diğer Ölçütler

- Nüfusun Özelliklerine İlişkin Diğer Ölçütler
- Çocuk Düşürme Düzeyini Belirleyen Ölçütler
- Sağlık İnsan Gücü ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Boyutuna İlişkin Ölçütler
- İş Sağlığı Alanında Kullanılan Ölçütler
- Beslenme Düzeyini Belirlemede Kullanılan Ölçütler
- İş Göremezlik Durumu (Disability) Ölçütleri
- Diş Sağlığı Düzeyini Belirlemede Kullanılan Ölçütler

Hastalık Sıklığının Ölçülmesi

- Hastalık sıklığına ilişkin çeşitli ölçümler, prevalans ve insidans kavramlarına dayandırılmaktadır.
- Risk Altındaki Nüfus: Hastalık sıklığı ölçümlerinin hesaplanmasındaki önemli bir faktör, araştırma kapsamında yer alan insan sayılarının doğru tahmin edilmesidir.
- İdeal olarak, bu sayılara sadece araştırılmakta olan hastalıklara, potansiyel olarak yatkın insanlar dahil edilmelidir.
    - Örneğin, serviks kanseri sıklığı hesaplanırken erkekler buna dahil edilmemelidir

Serviks Karsinomu Araştırmasında Risk Altında Bulunan Nüfus



Risk Altındaki Nüfus

- Belirli bir hastalığa yatkın insanlar, risk altındaki nüfus olarak adlandırılır ve demografik, coğrafî veya çevresel faktörlerle tanımlanabilir.
  - Örneğin, iş kazaları sadece çalışan insanlar arasında meydana gelir, yani risk altındaki nüfus burada iş gücüdür. Bazı ülkelerde bruselloz sadece enfekte olmuş hayvanlarla çalışan insanlarda görülmektedir, yani risk altındaki nüfus çiftliklerde ve mezbahalarda çalışanlardan oluşmaktadır.

İnsidans ve Prevalans

- Hastalık insidansı: belirtilen nüfusta belirli bir sürede ortaya çıkan yeni vakaların görülme hızı
- Prevalans: zaman içinde belirli bir noktada tanımlanan nüfustaki mevcut vakaların sıklığıdır.
- Bunlar, hastalığın ortaya çıkma sıklığının ölçülmesinde kullanılan temelde farklı olan yöntemlerdir.

Tablo 2.2.İnsidans ve Prevalans Arasındaki Farklar

	İnsidans	Prevalans
Pay	Belirtilen süre boyunca **yeni** hastalık vakalarının sayısı	Zaman içinde belirli bir noktadaki **mevcut** hastalık vakalarının sayısı
Payda	Risk altındaki nüfus	Risk altındaki nüfus
Odak	Olgunun yeni bir vaka olup olmadığı Hastalığın başlangıç zamanı	Bir hastalığın mevcut olması ya da olmaması Zaman dilimi isteğe bağlıdır; daha ziyade zaman içindeki bir "enstantane" dir.
Kullanımlar	Hastalanma riskini ifade eder Akut hastalıklar veya durumlara ilişkin ana ölçüdür, ancak kronik hastalıklar için de kullanılır Nedensellik araştırmalarında daha yararlıdır	Araştırılmakta olan dönemde insanların hastalanma olasılığını tahmin eder. Kronik hastalık yükünün ve sağlık hizmetlerinin etkisinin araştırılmasında faydalıdır.

Not: Eğer insidans vakaları çözüme kavuşturulmaz ve zaman içinde devam ederse, mevcut (prevalans) vakalar halinde gelir. Bu anlamda, prevalans = insidans x süre.

İnsidans ve Prevalans

- Insidans ile prevalans arasındaki ilişki hastalıklara göre farklılık göstermektedir.
- Düşük insidans ve yüksek prevalans diyabette olduğu gibi veya yüksek insidans ve düşük prevalans soğuk algınlığında olduğu gibi söz konusu olabilir.
- Soğuk algınlığı, diyabete göre daha sık görülmekle birlikte çok kısa zaman sürerken, diyabet yaşam boyu sürmektedir.

İNSİDANS

- Risk altındaki sağlam kişilerin, belirli bir sürede, bir hastalığa yakalanma olasılığıdır. Bir toplumda belirli bir sürede saptanan yeni vaka sayısının aynı toplumun yıl ortası nüfusuna bölünmesiyle elde edilir.
- İnsidans hızı, toplumun sürekli izlenmesi, sağlık ile ilgili kayıtların tam ve doğru olarak tutulmasıyla veya ileriye dönük araştırmalardan elde edilebilir.

$$\text{İnsidans} = \frac{\text{Bir toplumda belirli bir sürede saptanan yeni vaka sayısı}}{\text{Aynı toplumun yıl ortası nüfusu veya risk altındaki toplum}} \times k$$

PREVALANS - 1

- Belirli bir zaman kesitinde, toplumda bulunan toplam (eski + yeni) vaka sayısının aynı zaman kesitindeki risk altındaki kişi sayısına bölünmesiyle elde edilir. Bir hastalığın o zaman kesitinde toplumda görülme sıklığını gösterir.

1. **Nokta Prevalans:** Toplumda belirli bir andaki, örneğin gün veya diğer bir zaman kesitindeki toplam vaka (yeni + eski) vaka sayısıdır.

$$\text{Nokta Prevalans} = \frac{\text{Bir toplumda belirli bir andaki toplam vaka sayısı}}{\text{Risk altındaki toplum}} \times k$$

PREVALANS - 2

2- Süre Prevalans: Toplumda belirli bir süre (hafta, ay, yıl) içindeki toplam vaka sayısıdır.

- Ayrı ayrı elde edilme olanakları varsa nokta prevalans, süre prevalansdan daha anlamlıdır.
  - Nokta prevalansla belirli bir andaki tüm eski ve yeni vakalar saptanır. Daha sonra da insidans ile hasta popülasyonuna belirli bir sürede ne kadar yeni hasta kişinin katıldığı saptanabilir.

ATAK HIZLARI - 1

- İnsidansın bulaşıcı hastalıklar alanında kullanılan şeklidir. Belirli bir süre içinde saptanan bulaşıcı hastalık vaka sayısının, o hastalığa duyarlı kişi sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Primer Atak Hızı

- Bu ölçüt, salgının yaygınlığını, boyutunu ölçmek için kullanılır.
- İlk vakanın saptanmasından itibaren, en uzun bir kuluçka süresi içinde saptanan vaka sayısının, duyarlı kişi sayısına bölünmesiyle elde edilir.

$$\text{Primer Atak Hızı} = \frac{\text{Primer vaka sayısı}}{\text{Risk altındaki kişi sayısı}} \times k$$

ATAK HIZLARI - 2

Sekonder Atak Hızı

- Bu ölçüt, salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemlerin ne derecede etkili olduğunu gösterir.
- En uzun ikinci kuluçka süresi içinde görülen vaka sayısının duyarlı kişi sayısına bölünmesiyle elde edilir. Primer vakalar paydada yer almaz.

$$\text{Sekonder Atak Hızı} = \frac{\text{Hastalığın ikinci en uzun kuluçka döneminde ortaya çıkan vaka sayısı}}{\text{Risk altındaki kişi sayısı} - \text{Primer vakalar}} \times k$$

ÖRNEK

- Bir bölgede, bir kabakulak salgınında ilk vaka görüldükten sonra 170 ailede toplam 400 çocuk arasında saptanan vakaların dağılımı incelenmiş ve aşağıdaki tablo çıkarılmıştır: (Kabakulak kuluçka süresi 26 gündür)

İlk vakanın teşhisinden sonra geçen gün sayısı	Vaka sayısı
0 - 26	253
27 - 52	23
Toplam	276

$$\text{Primer Atak Hızı} = \frac{\text{0 – 26 gün içinde saptanan vakalar}}{\text{Toplam duyarlı çocuk sayısı}} \times 100$$

$$= \frac{253}{400} \times 100 = \%\,63{,}3$$

$$\text{Sekonder Atak Hızı} = \frac{\text{27 - 52. günler arasında saptanan vakalar}}{\text{Toplam duyarlı çocuk sayısı – Primer vakalar}} \times 100$$

$$= \frac{23}{400 - 253} \times 100 = \%\,15{,}7$$

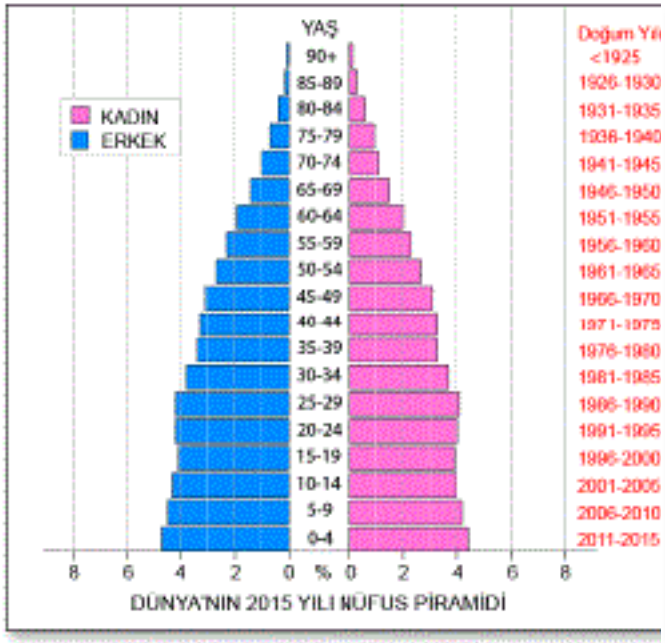
Bir Gıdaya Özel Atak Hızı

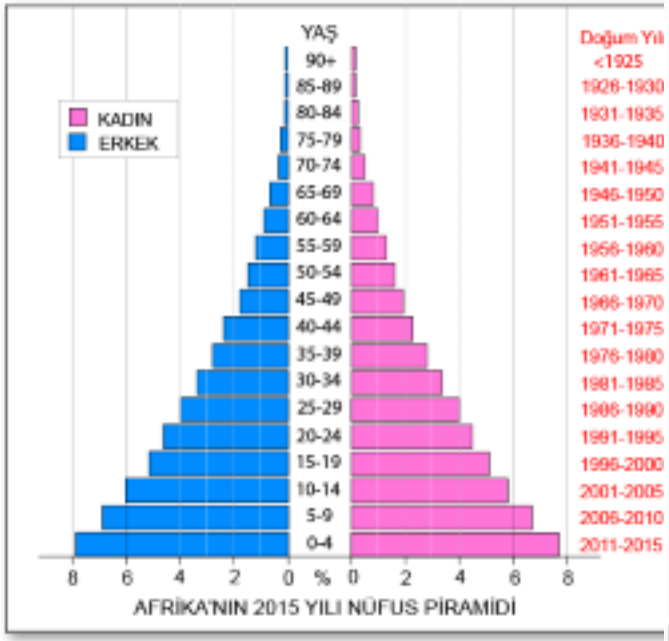
- Gıda zehirlenmelerini incelerken, zehirlenmeye hangi yiyeceğin neden olduğunu göstermek için kullanılır.
- Laboratuvar olanaklarının yeterli olmadığı durumlarda, ilk aşamada zehirlenmeye neden olan gıdaların belirlenmesine yardımcı olur.

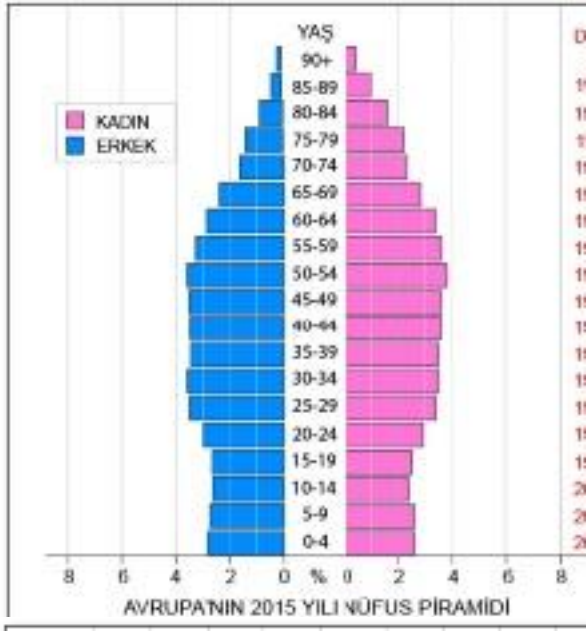
$$\text{"X" Gıdasına Özel Atak Hızı} = \frac{\text{"X" gıdasını yiyen ve hasta olan kişi sayısı}}{\text{"X" gıdasını yiyen toplam kişi sayısı}} \times k$$

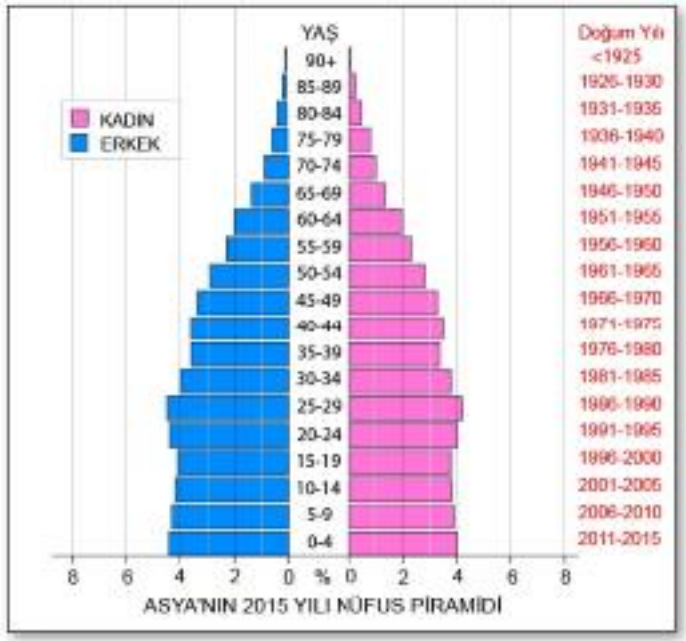
Sağlık Göstergeleri

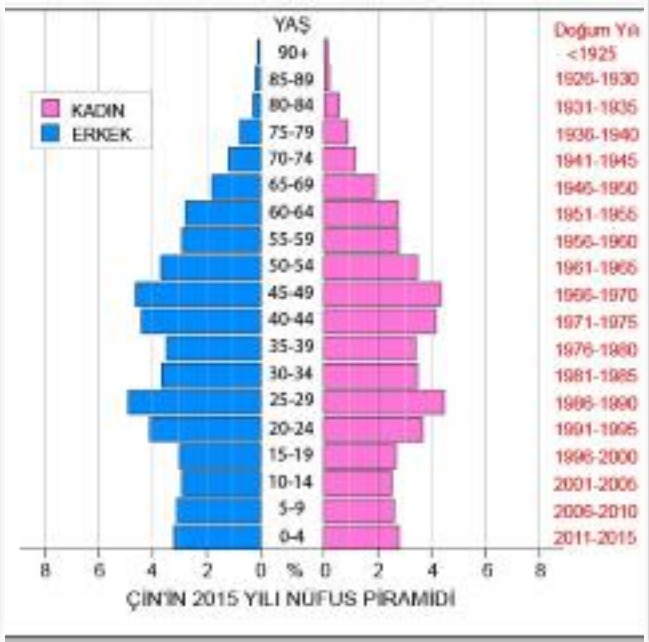
Yaş Dağılımı – Dünyadaki Durum

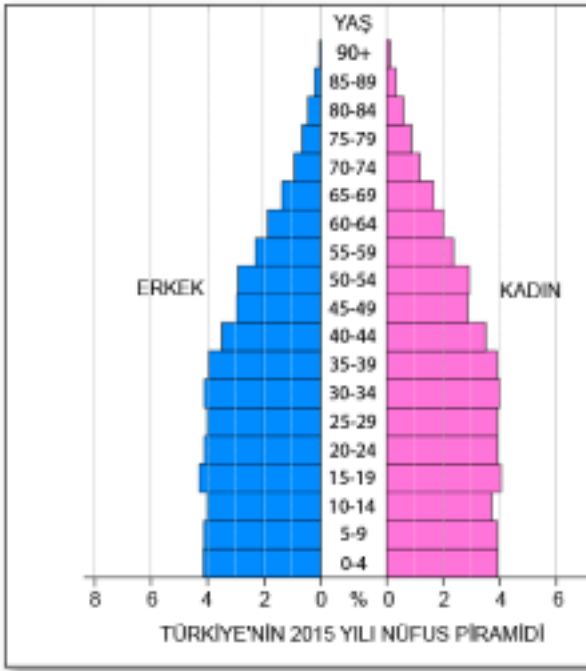








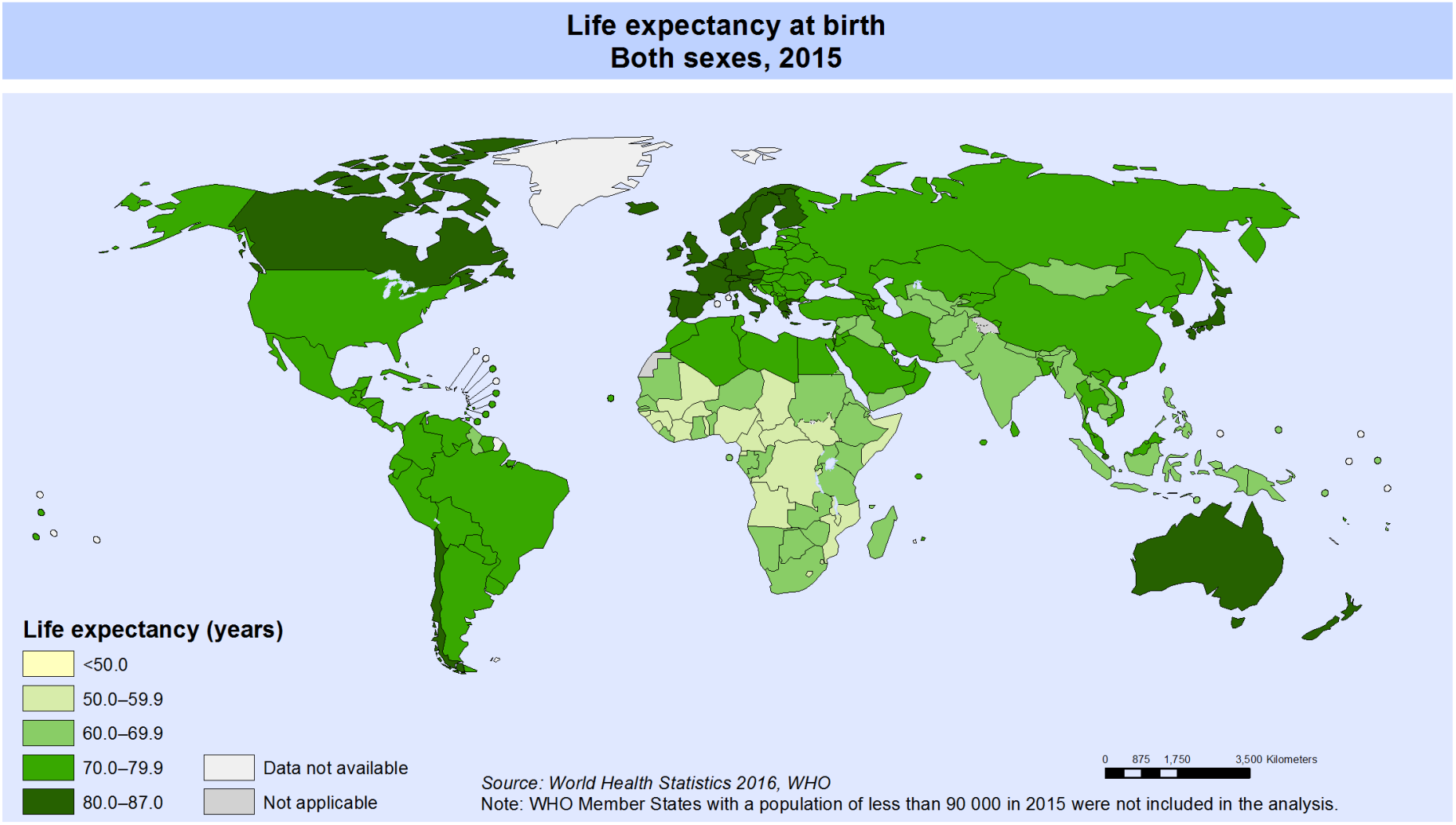




Ortalama Yaşam Bekletisi Süresi

- 2015'de dünyada doğumda yasam beklentisi ortalama 71.4 sene idi.
  - Kadınlarda 73.8 ve erkeklerde 69.1sene.
    - Kadın erkek arasındaki fark uzun yıllar ayni kalmıştır (1990 da fark 4.5 iken 2015'te bu fark 4.6 idi.
  - Dünya sağlık örgütünün Afrika bölgesinde ortalama 60 Avrupa bölgesinde 76.8.
  - Dünyanın averaj yasam beklentisi 2000 ile 2015 yılları arasında 5 sene artmıştır; bu 1960'dan itibaren görülen en fazla artıştır.
    - Bu yıllar arasındaki artış en çok Afrika bölgesinde görülmüştür (Çoğunlukla çocuk ölümlerindeki azalış ve HIV'nin tedavisine erişimin artışı ile yasam beklentisi 9.4 sene artmıştır.)

Tüm Dünyada Doğumda Yasam Beklentisi Oranları (Kadın – Erkek ortalaması)



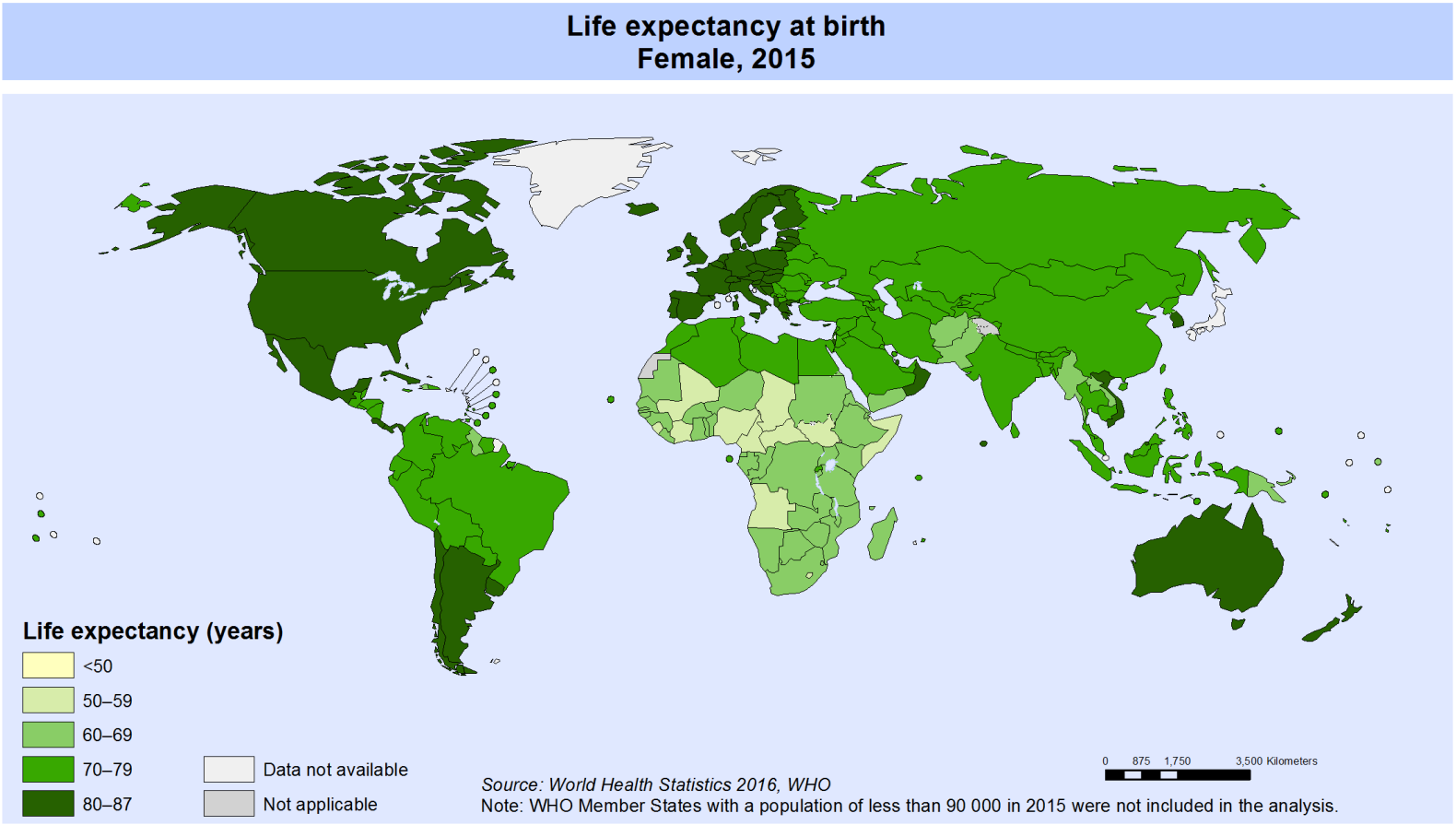
The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source: World Health Organization
Map Production: Information Evidence and Research (IER)
World Health Organization

World Health Organization

© WHO 2016. All rights reserved.

Tüm Dünyada Doğumda Yasam Beklentisi Oranları (Kadın)



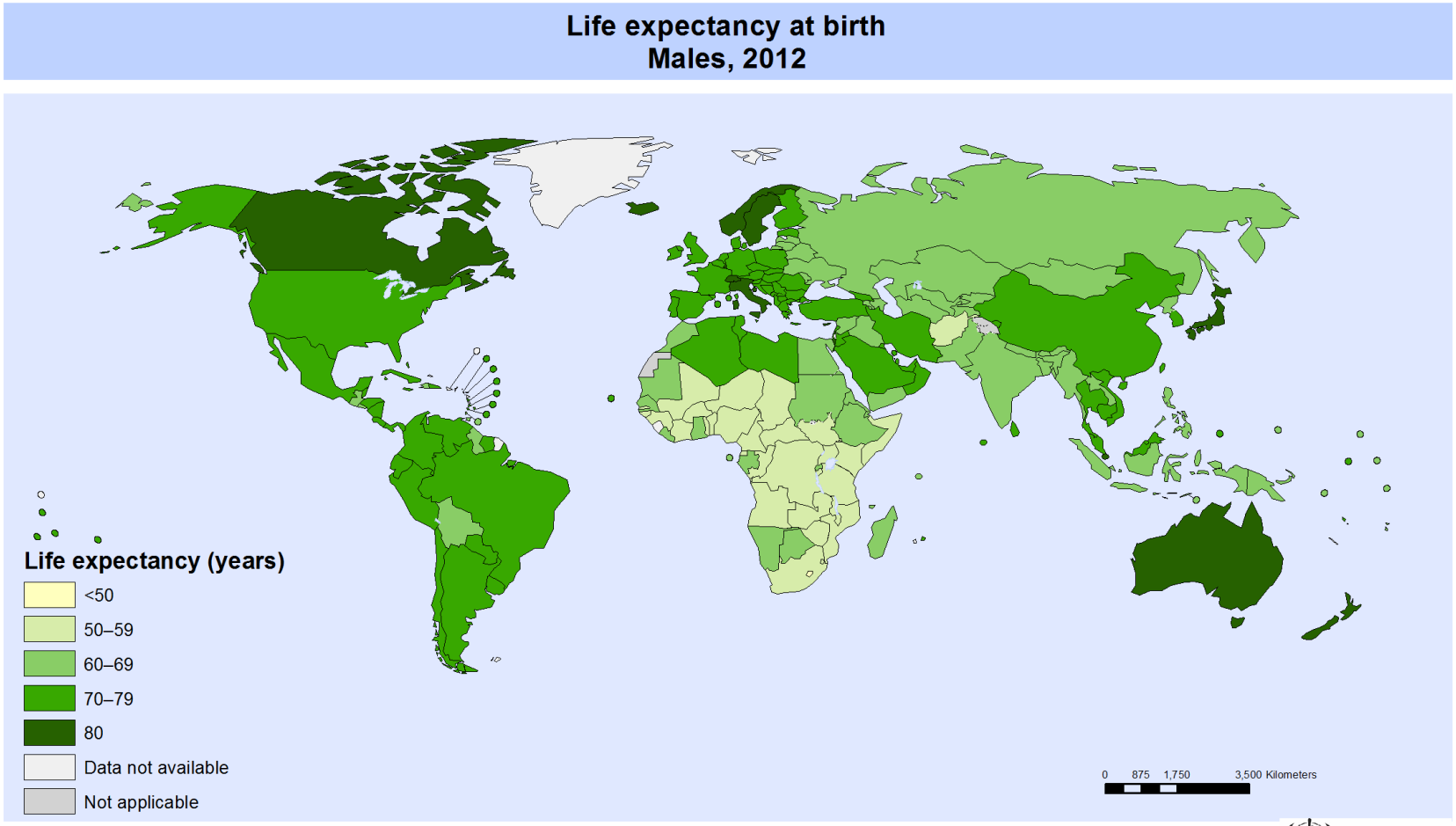
The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source: World Health Organization
Map Production: Information Evidence and Research (IER)
World Health Organization

World Health Organization

© WHO 2016. All rights reserved.

Tüm Dünyada Doğumda Yasam Beklentisi Oranları (Erkek)



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source: World Health Organization
Map Production: Health Statistics and Information Systems (HSI)
World Health Organization

World Health Organization

© WHO 2014. All rights reserved.

ÖLÜM Oranları

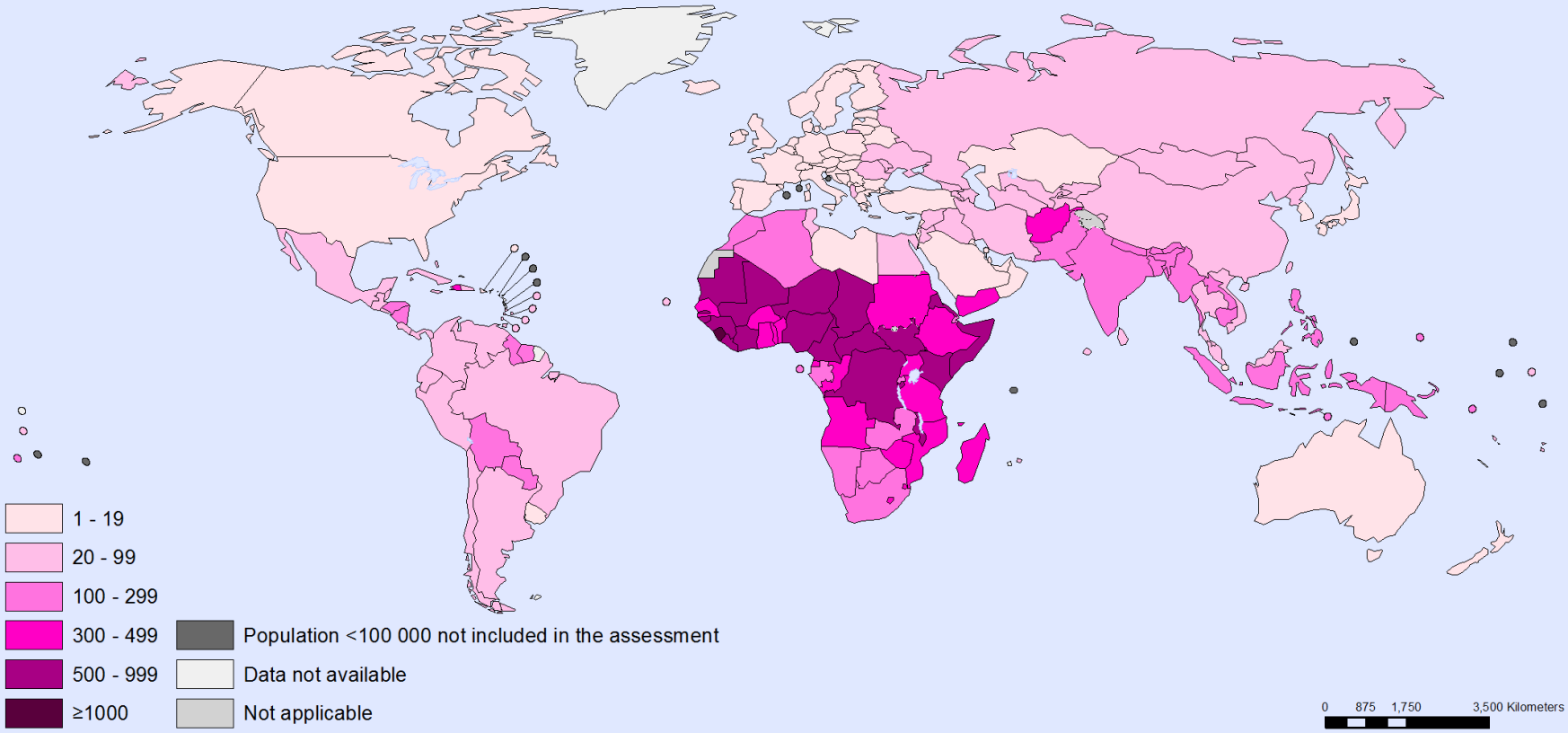
- Kaba Ölüm Hızı: 2015 yılında dünyada toplam 56.4 kişi hayatını kaybetti.
  - Iskemik kalp hastalığı ve inme dünyada en çok ölüme neden olan hastalıkların başında gelmektedir.
    - Toplam 15 milyon kişinin ölümüne neden olmuştur (2015).
    - Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıkları 3.2 milyon ölüme, akciğer kanseri ise 1.7 milyon ölüme neden olmuştur.
    - Diyabet 2015'te 1.6 milyon ölüme neden olurken, bu rakam 2000'de 1 milyondan azdı.

- http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/mbd/adult_mortality/atlas.html

Ana Ölüm Hızı

- İstatistiklere göre günde ortalama 830 kadın hamilelik ve doğuma bağlı önlenebilen komplikasyonlara bağlı ölmektedir.
  - 2015'te yaklaşık 303 000 kadın hamilelik veya doğuma bağlı hayatını kaybetmiştir.
  - Bu ölümlerin 99%'u gelişmekte olan ülkelerde olmaktadır.
  - 2015 yılında gelişmekte olan ülkelerdeki ana olumu 100 000 canlı doğumda 239 iken gelişmiş ülkelerde bu rakam 100 000'de 12 idi.
- Ana ölümleri kırsal kesimlerde yasayan ve fakir toplumlarda daha yüksektir.
- 1990 ve 2015 arasında anne ölümlerinde 44% oranında düşüş yaşanmıştır.
- 2016 – 2030 yılları arasında hedef ana olum hızını 100 000 canlı doğumda 70'e düşürmektir.

Maternal mortality ratio (per 100 000 live births), 2015



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

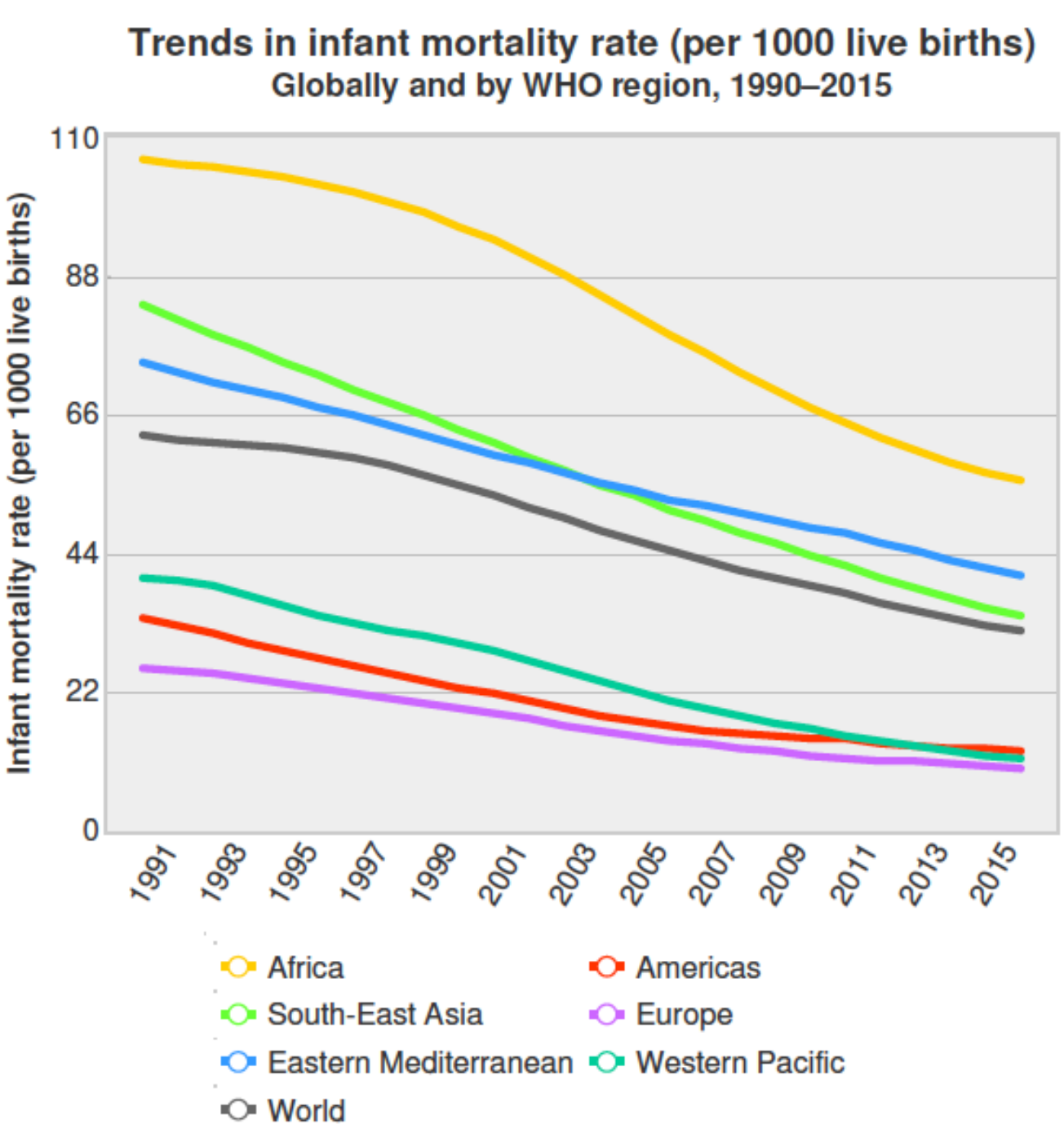
Data Source: World Health Organization
Map Production: Health Statistics and Information Systems (HSI)
World Health Organization

World Health Organization

© WHO 2015. All rights reserved.

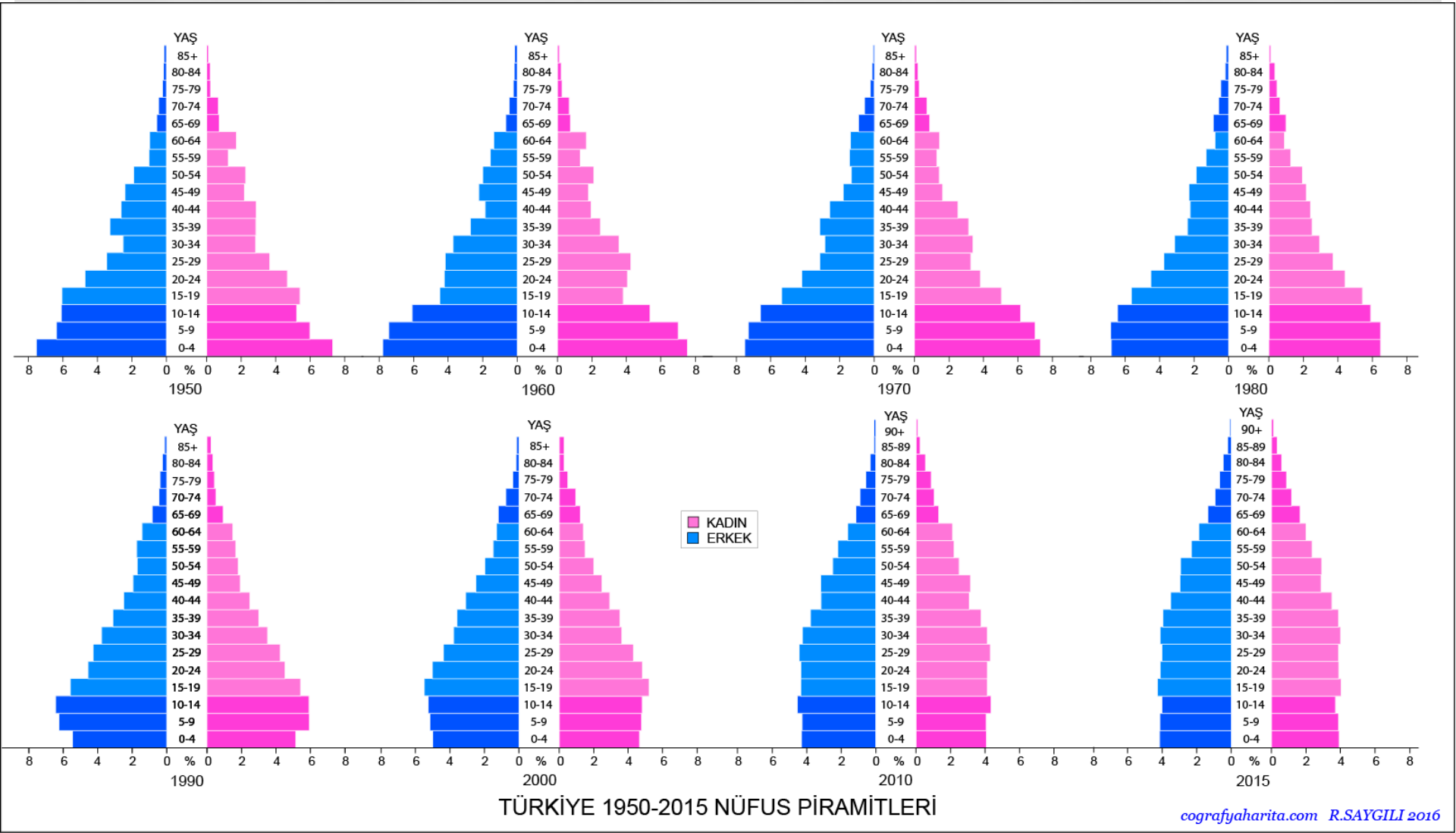
Bebek Ölüm Hızı

- 2015'te 4.5 milyon ölüm 1 ve altındaki yaslardaki bireylerde meydana gelmiştir.
  - Bu 5 yas altı çocuk ölümlerinin 75%'ine eşittir.
- İlk bir sene içinde gerçeklesen ölümler Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika bölgesinde Avrupa bölgesinden 5 kattan daha fazla orandadır. (Afrika bölgesinde 1000 canlı doğumda 55 iken bu Avrupa bölgesinde 1000'de 10 oranındadır.
- Bebek ölüm oranı 1990'dan 2015'e 1000'de 63'ten 1000'de 32'e düşmüştür.

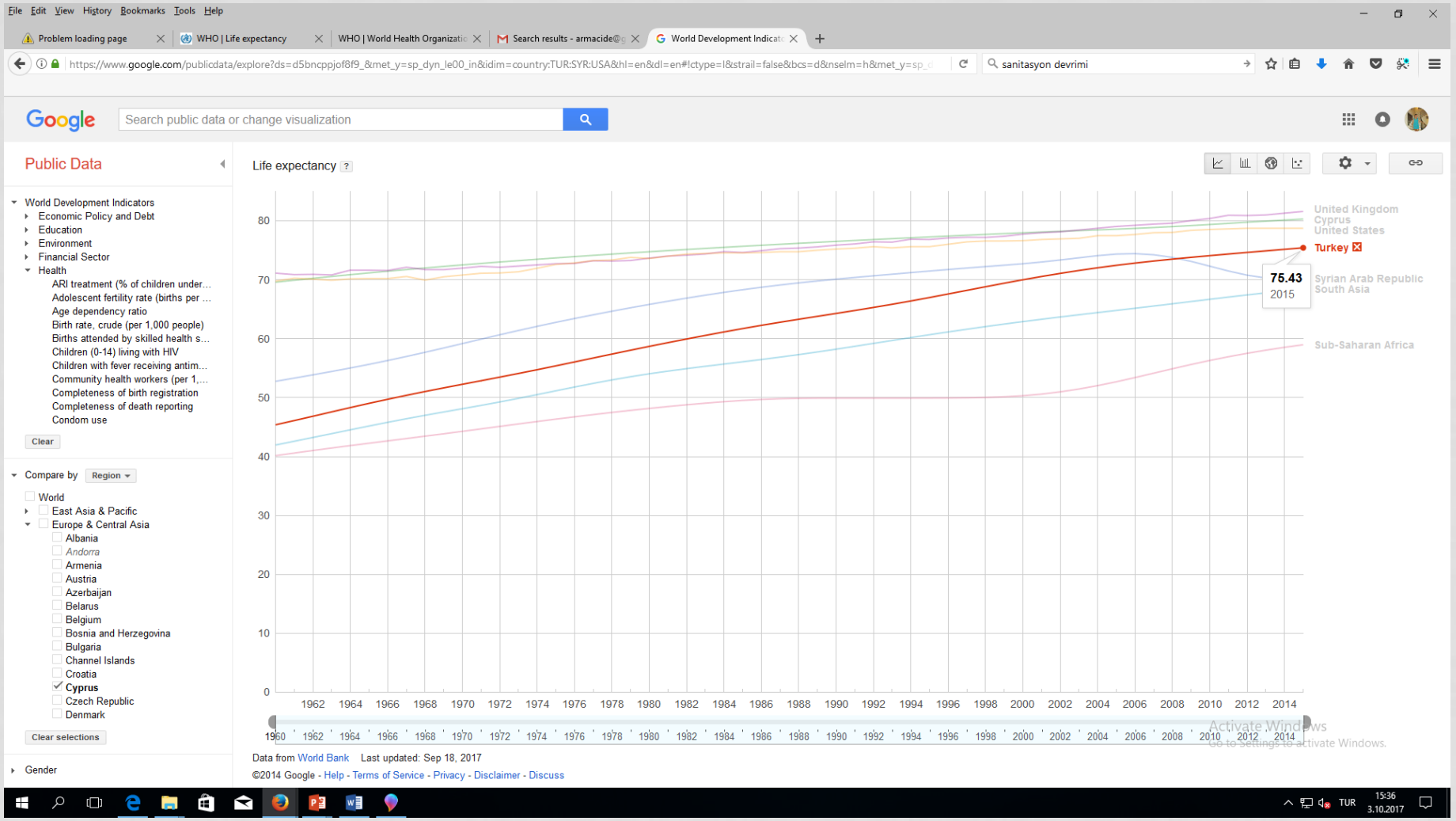

Trends in infant mortality rate (per 1000 live births)
Globally and by WHO region, 1990–2015
Infant mortality rate (per 1000 live births)
110
88
66
44
22
0
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Africa
Americas
South-East Asia
Europe
Eastern Mediterranean
Western Pacific
World

TÜRKİYE'DE DURUM

Yaş Dağılımı



Ortalama Yaşam Bekletisi Süresi



ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ

- Ölüm sayısı revize edilen 2015 yılı verisine göre 405 bin 202 iken bu sayı %4,2 artarak 2016 yılında 422 bin 135 kişi oldu. Ölenlerin %54,8'ini erkekler, %45,2'sini kadınlar oluşturdu.
- Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2015 yılında binde 5,2 iken 2016 yılında binde 5,3'e yükseldi. Diğer bir ifade ile 2015 yılında bin kişi başına 5,2 ölüm düşerken, 2016 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düştü.
- Bebek ölüm sayısı, revize edilen 2015 yılı verisine göre 13 bin 654 iken 2016 yılında 13 bin 36 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2015 yılında binde 10,2 iken 2016 yılında binde 10 oldu. Diğer bir ifade ile 2016 yılında bin canlı doğum başına 10 bebek ölümü düştü.

BEBEK ÖLÜM HIZI

Bebek ölüm hızının en yüksek ve en düşük olduğu ilk 5 il, 2015, 2016

(‰)

2015(r)				2016			
En yüksek iller	Bebek ölüm hızı	En düşük iller	Bebek ölüm hızı	En yüksek iller	Bebek ölüm hızı	En düşük iller	Bebek ölüm hızı
Şanlıurfa	18,3	Bartın	3,8	Bingöl	18,2	Tunceli	3,1
Kilis	18,2	Kırklareli	4,9	Şanlıurfa	18,0	Artvin	5,5
Van	16,4	Rize	5,2	Hakkari	15,3	Gümüşhane	5,8
Şırnak	15,9	Edirne	5,4	Muş	15,0	Karabük	5,9
Gaziantep	15,5	Karabük	5,6	Şırnak	14,3	Nevşehir	6,1

(r) Ölüm verileri güncel idari kayıtlarla revize edilmiştir.

ÖLÜM NEDENLERİ

Ölüm nedenlerinin dağılımı, 2016, 2017

	2016 (r)		2017	
	Sayı	(%)	Sayı	(%)
Toplam	**420 189**	**100,0**	**416 881**	**100,0**
Dolaşım sistemi hastalıkları	166 069	39,5	165 323	39,7
İyi huylu ve kötü huylu tümörler (malign ve benign neoplazmlar)	81 647	19,4	81 527	19,6
Solunum sistemi hastalıkları	49 295	11,7	49 855	12,0
Endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar	20 731	4,9	20 110	4,8
Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları	20 220	4,8	20 504	4,9
Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler	21 473	5,1	18 901	4,5
Diğer (enfeksiyon ve parazit hastalıkları, mental ve davranışsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi ve bağ dokusunun hastalıkları vb.)	60 754	14,5	60 661	14,6

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
(r) 2016 yılı verileri idari kayıtların güncellenmesi nedeniyle revize edilmiştir.

ÖLÜM NEDENLERİ

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölümlerin alt gruplara göre dağılımı, 2016, 2017

	2016 (r)		2017	
	Sayı	(%)	Sayı	(%)
Dolaşım sistemi hastalıkları	**166 069**	**100,0**	**165 323**	**100,0**
İskemik kalp hastalığı	67 412	40,6	65 666	39,7
Serebro-vasküler hastalık	38 959	23,5	37 885	22,9
Diğer kalp hastalığı	37 077	22,3	38 606	23,4
Hipertansif hastalıklar	14 537	8,8	14 706	8,9
Diğer	8 084	4,9	8 460	5,1

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
(r) 2016 yılı verileri idari kayıtların güncellenmesi nedeniyle revize edilmiştir.

TÜMÖRE BAĞLI ÖLÜMLER

- Kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2017 yılında 79 bin 889 kişi oldu. Bu ölümlerin %31'i gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandı.

Kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin alt gruplara göre dağılımı, 2016, 2017

	2016 (r)		2017	
	Sayı	(%)	Sayı	(%)
Kötü huylu tümörler (malign neoplazmlar)	**79 970**	**100,0**	**79 889**	**100,0**
Gırtlak ve soluk borusu / bronş / akciğerin kötü huylu tümörü	24 840	31,1	24 750	31,0
Midenin kötü huylu tümörü	6 917	8,6	6 687	8,4
Lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümör	6 469	8,1	6 417	8,0
Kolonun kötü huylu tümörü	5 816	7,3	6 091	7,6
Pankreasın kötü huylu tümörü	4 788	6,0	4 920	6,2
Diğer	31 140	38,9	31 024	38,8

(r) 2016 yılı verileri idari kayıtların güncellenmesi nedeniyle revize edilmiştir.